

Podłoże AvPD

Cztery poziomy: *biologia* (BI, amygdala) × *genetyka* (dziedziczność ~64%) × *środowisko* (krytyka, odrzucenie). Same geny ani środowisko nie wystarczą.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna

ŹRÓDŁO: Kagan (1989); Reichborn-Kjennerud (2007); Joyce (2003); Bamelis (2014)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz *cztery poziomy etiologii* AvPD (sekcja 01): *biologia*, *genetyka*, *środowisko*. **2** · Poznasz mechanizm interakcji *temperament* × *środowisko* (sekcja 02). **3** · Sprawdzisz, które czynniki dotyczą *Twojej historii* (sekcja 03). **4** · Zobaczysz **trzy główne schematy YSQ** w AvPD (sekcja 04): defektywność, izolacja, podporządkowanie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

AvPD różni się od lęku społecznego (SAD) *jakościowo*: chroniczne, wewnętrzne przekonanie o defektywności. „Pragnę bliskości, ale jestem fundamentalnie niegodny/-a”. Trzy poziomy etiologii: **biologia** (Kagan 1989: BI + nadreaktywna amygdala), **genetyka** (Reichborn-Kjennerud 2007: dziedziczność ~64%), **środowisko** (Joyce 2003: krytyka, zaniedbanie emocjonalne, bullying). Bamelis 2014: terapia schematów 74% wyzdrowienia vs CBT 32% — praca z trybami Schema Therapy (Detached Protector, Lonely Child, Punitive Parent), nie tylko z myślami.

01 📖 Cztery poziomy etiologii AvPD

1 · BIOLOGIA

Temperament BI (~15% niemowląt). Nadreaktywna amygdala — Schwartz 2003: u dorosłych z BI w dzieciństwie zostaje 20 lat później. Niski próg pobudzenia układu współczulnego. Wrażliwy system alarmowy.

2 · GENETYKA

Dziedziczność ~64% (Reichborn-Kjennerud 2007, badanie bliźniąt). Krewni 1. stopnia: 5× wyższe ryzyko AvPD, 2× ryzyko lęku społecznego. Wspólna predyspozycja z innymi zaburzeniami klastra C. Geny: 5-HTTLPR, BDNF, RGS2.

3 · ŚRODOWISKO

Krytyka rodzicielska („nigdy nie jesteś wystarczający/-a”), zaniedbanie emocjonalne (rodzic *nieobecny* emocjonalnie), bullying szkolny. *Chroniczna* trauma emocjonalna (vs *akutna* fizyczna w BPD).

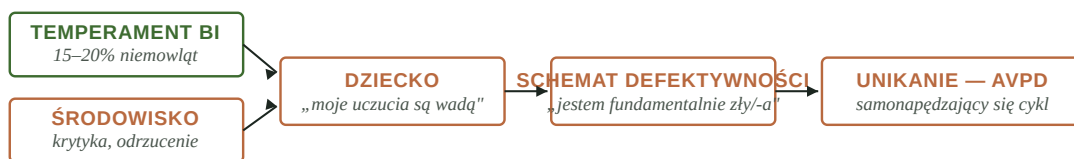
4 · SCHEMATY YSQ + TRYBY

Bamelis 2014: trzy główne schematy Younga — *defektywność/wstyd*, *izolacja społeczna*, *podporządkowanie*. Tryby Schema Therapy: *Detached Protector* (odcięcie emocjonalne), *Lonely Child* (nieuznane potrzeby bliskości), *Punitive Parent* (introjekt krytycznego rodzica).

Klucz interakcji: same geny *nie* wystarczą; samo środowisko *nie* wystarczy. Potrzebne **oba**. Fox 2005: dzieci z BI w *ciepłym* środowisku **nie** rozwijają zaburzenia. To dobra wiadomość: nawet jeśli temperament zostaje, środowisko terapii i nowe relacje mogą zmienić interpretację „*moja reakcja = moja wada*”.

02 Mechanizm: temperament × środowisko

Klucz interakcji: same geny *nie* wystarczą; samo środowisko *nie* wystarczy. Potrzebne **oba**. Fox i wsp. (2005): dzieci z BI w *ciepłym, walidującym* środowisku **nie** rozwijają zaburzenia. Diateza-stres — biologiczna podatność spotyka się ze stresem środowiskowym.



Wrażliwy BI + krytyczne środowisko → dziecko internalizuje „moja reakcja = moja wada”. Rdzeń AvPD: **defektywność jako tożsamość**.

03 Twoja historia — czynniki ryzyka

TEMPERAMENT W DZIECIŃSTWIE

— byłem/-am wycofany/-a, ostrożny/-a w nowych sytuacjach?

RODZICE — KRYTYCZNI CZY WALIDUJĄCY?

— „nigdy nie jesteś wystarczający/-a”?

BULLYING / ODRZUCENIE RÓWIEŚNICZE

— szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum?

INNE CZYNNIKI

— przeprowadzki, zmiany szkoły, choroba w rodzinie?

04 Trzy główne schematy YSQ w AvPD

1 · DEFEKTYWNOŚĆ / WSTYD

„Jestem **fundamentalnie** wadliwy/-a. Gdyby ktoś mnie naprawdę poznał, odrzuciłby mnie.” Rdzeń AvPD.

2 · IZOLACJA SPOŁECZNA

„Jestem *inny/-a*, nie pasuję. Nigdzie nie należę.”
Poczucie obcości — także w grupach „swoich”.

3 · PODPORZĄDKOWANIE

„Muszę spełnić oczekiwania innych — moje potrzeby się *nie liczą*.” Brak autonomii, kompulsywna ugodowość.

Klucz: AvPD *nie* jest „skrajną nieśmiałością”. Wynika z **interakcji** trzech poziomów: biologii (BI, nadreaktywna amygdala), genetyki (dziedziczność ~64%, Reichborn-Kjennerud 2007), środowiska (krytyka, zaniedbanie emocjonalne, bullying — Joyce 2003). Same geny ani samo środowisko *nie* wystarczą; potrzebna **interakcja**. Rdzeń kliniczny: trzy schematy Younga — *defektywność, izolacja, podporządkowanie*. Stąd standardowa CBT (kwestionowanie myśli) jest *niewystarczająca* — Bamelis 2014: terapia schematów osiąga 74% wyzdrowienia vs 32% CBT. **Diagnoza otwiera drogę do skutecznego leczenia.**